

データの成り立ち

医薬品供給状況 検索システム / 2026年9月時点

1. 区分の関係

区分どうしの関係

全16,393品目(2026年9月1日版)での実測値です。

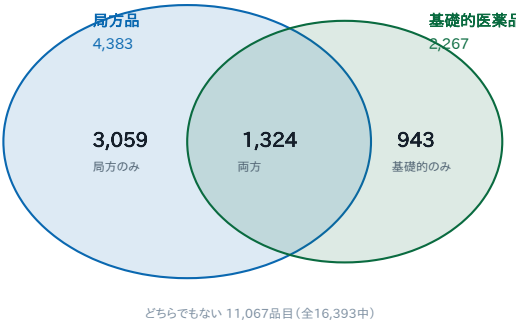
1. 製品区分は互いに重ならない

6つの区分は、1品目につき必ず1つだけが割り当てられ、合計すると全品目になります。

製品区分	品目数	割合	バッジ
後発品	7,239	44.2%	後
その他医薬品	4,073	24.8%	他
先発品	2,903	17.7%	先
長期収載品	1,254	7.6%	長期
未収載医薬品	824	5.0%	未
準先発品	100	0.6%	準先
合計	16,393	100%	

2. 局方品・基礎的医薬品は製品区分と独立

この2つは製品区分の上に重なる属性で、どの区分の薬にも付きえます。



3. 「基」と「変更可」は別の制度

変更調剤の可否は「変更可」バッジだけで判断してください。

「基」の有無は関係ありません。厚労省の一覧の正式名称が「後発医薬品と同様に変更調剤が認められる基礎的医薬品等の一覧」で、この「等」に基礎的医薬品でないものが含まれるためです。

パターン	バッジ	意味
基のみ	基	基礎的医薬品だが 変更調剤は不可
基+変更可	基 変更可	基礎的医薬品で 変更調剤も可
変更可のみ	変更可	基礎的医薬品ではないが 変更調剤は可

4. 選定療養と併売品

後から追加した2つの属性です。いずれも製品区分とは独立しています。

バッジ	品目数	意味
選	776	長期収載品の選定療養の対象。長期収載品を中心に、準先発品・先発品・その他医薬品にもまがります
併売	280	同じ成分・剤形・規格で商品名が異なる薬（ノルバスクとアムロジンなど）

併売品は61成分・280品目です（内用薬・外用薬の場合。注射薬を含めると68成分）。うち入手可否が分かれるのは8成分で、供給停止時の代替候補を探すのに使えます。

2. 出典の対応

どの表示が、どこから来ているか

出典の記号

供給

 医療用医薬品供給状況（厚労省・毎日確認）

薬価

 薬価基準収載品目リスト（厚労省・毎日確認）

基礎

 変更調剤が認められる基礎的医薬品等（厚労省・毎日確認）

選定

 選定療養の対象医薬品リスト（厚労省・毎日確認）

一般

 一般名処方マスタ（厚労省・毎日確認）

手動

 discontinued.txt（利用者が登録）

計算

 生成時に算出（複数データの突合・前回との比較）

端末

 閲覧時にブラウザで計算

単一データから直接出る項目

表示	出典	元の項目
薬剤名／規格／製造販売業者	供給	⑥④⑦
供給状況（通常／限定／停止）	供給	⑫出荷対応の状況
剤形タグ（内用／外用／注射）	供給	①薬剤区分
製品区分バッジ	供給	⑧製品区分
基バッジ	供給	⑨基礎的医薬品

成分名／薬効分類／YJコード	供給	③②⑤
理由／解除見込／備考／出荷量	供給	⑭⑮⑯⑰

複数のデータを突合している項目

表示	出典	結び方
薬価	薬価	YJコードで結合（2段階／後述）
局バッジ	薬価	同上。「局」欄の有無
経過措置期限	薬価	YJコード完全一致のみ
変更可バッジ	基礎	薬剤名で結合（コードが無いため）
選バッジ／差額分・選定療養時の薬価	選定	薬価基準収載医薬品コードで完全一致（対象は銘柄別収載品なのでYJコードと同じ12桁）
販売中止バッジ	手動	薬剤名→YJコードに変換して結合
【般】一般名処方で検索／調剤可能な品名	一般	一般名コード（YJ先頭9桁＋例外は12桁）で結合
併売バッジ／併売品の一覧	計算	YJ先頭9桁＋製品区分＋商品名で判定
悪化／改善	計算	前回版の供給状況と比較
剤形（詳細）	計算	品名＋YJコード8桁目から判定
「後発品が高い」一覧	計算	YJ先頭9桁で群化し薬価を比較
お知らせ掲示板／推移グラフ	計算	過去の版の履歴から算出

閲覧時にブラウザで計算する項目

表示	内容
「〇日前の版」	供給データの日付と端末の今日の差
経過措置の残り日数・色	期限と端末の今日の差
後発品との差額（カード内）	点数換算を含む正確な計算（計算タブと同じ）
「計算」タブの金額	入力内容から点数を算出
フィルターの並び順	端末に保存され、次回も同じ並びになります

上の2つは端末の日付で毎回計算するため、ページを作り直さなくても日数が進みます。端末の日付がずれていると表示もずれます。

外部に委ねている項目

添付文書・IF・RMP のボタンは、YJコードからPMDAのURLを組み立てているだけで、内容は一切保持していません。最新版の判定はPMDA側が行うため、改訂があっても自動的に最新が開きます。

3. 結合の仕組み

データの流れ

毎朝7時・自動



結合キーの使い分け

コードの桁の意味

このシステムの突合はすべて、12桁のコードのどこまでが一致するかで決めています。まず各桁が何を表すのかを示します（例:ユーロジン錠2mg）。

1	1	2	4	0	0	1	F	2	0	3	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

■ 1～4桁 薬効分類

■ 5～7桁 投与経路・成分

■ 8桁目 剤形

■ 9桁目 規格単位

■ 10～11桁 同一規格内の番号

■ 12桁目 チェックデジット

つまり上9桁が一致すれば、成分・剤形・規格が同じということです。このシステムが上9桁を多用しているのは、この構造によります。

① 薬価・局方 —— YJコードの2段階照合

12桁の完全一致だけでは3分の2しか当たりません。統一名収載品は、薬価基準収載医薬品コードが一般名に1つだけ付くのにに対し、YJコードは商品ごとに付くため、10～12桁目が食い違うからです。

供給状況のYJコード

薬価リスト側

2233002Q1 108 2233002Q1 108

① 12桁が完全一致 …………… 65.5%

2233002Q1 108 2233002Q1 019

② 上9桁で一致(統一名収載品)… +29.3%

合計 94.8% (残り5.2%=852品目のうち824品目は
未収載医薬品で、そもそも薬価が存在しない)
未収載医薬品を除いた突合率は 99.8%

経過措置期限だけは①のみです。期限は品目ごとに個別設定されるため、統一名から継承すると誤りになります。

② 変更調剤可 —— 薬剤名での照合

厚労省の変更調剤可リストにはコードが一切入っていません。そのため薬剤名の完全一致で突合しています。
全角・半角やカギ括弧は吸収しますが、コード照合より脆い点にご留意ください。

③ 選定療養 —— コードで完全一致

対象医薬品リストが持つのは薬価基準収載医薬品コードで、供給状況データのYJコードとは本来別のコードです。
ただし選定療養の対象は長期収載品で、いずれも銘柄別収載(商品名で薬価収載)のため両者の12桁は一致します。実測でも776件すべてが12桁で一致しました。

この一致は対象が銘柄別収載品だからこそ成り立ちます。仮に統一名収載品が対象に入れば、①の薬価と同じく下3桁がずれて当たらなくなります。そのときは上9桁の照合を足す必要があります。

適用開始日は「※令和8年6月1日から」という記載を読み取り、今日すでに始まっているもののうち最新版を選びます。将来分が先に公表されても、開始日が来るまでは採用しません。

④ 併売品 —— 3つの条件の組み合わせ

上9桁が一致すれば成分・剤形・規格は同じですが、それだけでは後発品も同じ9桁を共有します。そのため条件を重ねています。

条件1 YJ先頭9桁が一致 …… 中身が同じ

条件2 先発品・準先発品・長期収載品に限る … 後発品を除く

条件3 商品名の語幹が異なる …… 規格違いを除く

例) 先頭9桁 2171022F1 を共有する品目

○ ノルバスク錠2.5mg (長期収載品) ← 併売品

○ アムロジン錠2.5mg (長期収載品) ← 併売品

× アムロジピン錠2.5mg「〇〇」×21件 (後発品) … 条件2で除外

条件3は文字列の比較です。剤形を表す語(錠・カプセル・パップ等)の前までを商品名とみなしています。まれに取りこぼしや誤りが生じる可能性があります。

⑤ 悪化／改善と履歴

取得のたびに、状態が変わった日だけを記録

↓

YJコードごとに前回と比較

通常出荷(0) → 限定出荷(1) → 供給停止(2)

数値が上がった＝悪化 / 下がった＝改善

↓

この履歴から、お知らせ掲示板と推移グラフを作る

初回導入時は比較対象が無いため0件です。2回目の更新以降に機能します。

⑥ 「後発品が高い」 —— 群化してから比較

YJ先頭9桁で群化

↓

先発品・長期収載品の最安 と 後発品の最安 を比較

↓

先発 ≤ 後発の最安 のとき該当 (後発に変えても安くならない)

⑦ 一般名処方 —— 上9桁+ZZZ、例外だけ12桁

一般名コードは薬価基準収載医薬品コードの上9桁に「ZZZ」を付けた12桁です。つまり上9桁が共通する医薬品が、その一般名処方で調剤できる範囲になります。

供給状況データが持つのはYJコードですが、上9桁は薬価基準収載医薬品コードと共通(食い違うのは10～12桁目だけ)なので、上9桁で引く限りは同じ結果になります。例外コードだけは12桁の完全一致で引くため、厚労省

の対照表に載っている薬価基準収載医薬品コードと、YJコードが一致する品目に限られます。

【般】エスタゾラム錠2mg 1124001F2ZZZ

色を付けた上9桁が一致する品目を集める

↓

品名	YJコード
ユーロジン錠2mg	1124001F2039
エスタゾラム錠2mg「アメル」	1124001F2071
…など	

例外コードがある点に注意

上9桁では区別できない品目については、厚労省が 9桁目をアルファベットに置き換えた「例外コード」を割り当て、マスタに対照表を添付しています。放出制御型製剤などがこれにあたり、ここを取り違えると持続時間の違う薬を調剤してしまいます。そのため例外コードは12桁の完全一致で結び、上9桁の照合より先に引いています。

【般】チモロール点眼液0.25%（持続性） 1319702QAZZZ

9桁目がA=例外コード（上9桁では当たらない）

↓

対照表の12桁で結ぶ

- 1319702Q3010 Q3037 Q3045 Q3061 Q3088 Q5021 の6品目のみ

× 持続性でない チモプトール点眼液0.25% は含まれない

実測では一般名1,433件（現行版1,257件+過去の版から176件）、9桁の索引1,386件・例外の12桁索引150件で、両者の衝突はありません。供給状況データ側では6,852品目に一般名が付き、品目が1件以上ある一般名は1,412件です。

言い換えについて: マスタの記載は「口腔内崩壊錠」ですが、画面では「OD錠」でも引けるようにしています。表記の違いだけで「収載されていない」と誤解されるのを防ぐためです。

版をまたいで積み上げています

マスタは改訂のたびに品目が入れ替わり、**減ることもあります**。実測ではR7.12.4版の1,381件がR8.6.12版では1,230件になっており、【般】アムロジピン錠2.5mg・5mgなどが現行版から外れています。

同じ一般名コードがある → 新しい版で上書き
新しい版に無い記載 → そのまま残す（「旧版」と表示）

R7.12.4版 1,381件
R8.6.12版 1,230件 → 統合 1,433件
バイオ版 27件 （うち現行版に無いもの 176件）

過去分のリンクはいずれページから消えるため、前回の `ippanmei.json` も統合の材料にしています。一度取り込んだ記載は以後も残ります。

「旧版」の意味にご注意ください。マスタから外れたということは、その記載が **一般名処方加算の対象ではなくなった**ことを意味します。調剤できる品目の目安として残していますが、**加算の可否は現行のマスタでご確認ください**。絞り込みのチェックを外すと現行版だけになります。

このシステムの限界

データの正確性は厚労省の公表内容に依存します。公表データを整形・突合して表示するもので、独自の判断は加えていません。

ただし次の項目は**推定や近似を含みます**。

- ・ **剤形（詳細）** … 品名とYJコードからの判定。未収載品の一部は「その他」になります
- ・ **変更可** … 薬剤名での突合のため、表記が変わると外れる可能性があります
- ・ **併売品** … 商品名の文字列比較を含みます
- ・ **販売中止** … 手動登録。登録漏れや包装単位の取りこぼしが生じます
- ・ **一般名処方** … 一般名処方加算の対象品目についての標準的な記載であり、一般名処方の可否や記載方法を定めるものではありません。マスタに無い記載で処方されることもあります

処方判断など正式な用途では、必ず**厚労省の原本およびPMDAの電子添文**をご確認ください。

4. 計算の根拠

選定療養の計算根拠

「計算」タブの金額は、厚労省の事務連絡に沿って算出しています。

根拠:厚生労働省「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」(令和8年3月27日 事務連絡)

1. 3つの金額の関係

- ① 差額分の薬価 = (薬価 - 後発医薬品最高価格) ÷ 2
- ② 選定療養時の薬価 = 薬価 - 差額分の薬価

例) ヒルドイドソフト軟膏0.3% (1gあたり)

- ① $(17.7 - 6.3) \div 2 = 5.7$ 円
- ② $17.7 - 5.7 = 12$ 円

2026年6月1日から「4分の1」→「2分の1」に引き上げられました。解説記事の多くは導入当初(2024年10月)の4分の1のままなのでご注意ください。このシステムは厚労省の対象医薬品リストの値をそのまま使うため、改定があれば自動で追隨します。

2. 点数への換算

金額はそのまま足すのではなく、**薬剤料と同じ方法で点数に換算**します。

所定単位あたりの金額が
15円以下 → 1点
15円を超える → 10円で割って五捨五超入
(ちょうど0.5は切り捨て、0.5超で切り上げ)

この規則があるため、単純な掛け算とは大きくずれます。差額分1.25円の薬を1日1錠・5日分なら、単純計算では約7円ですが、実際は**55円**(1点×5日×10円×1.1)です。内服薬は最低でも1日あたり11円が発生します。

3. 所定単位は剤形で異なる

剤形	所定単位	計算
内服薬	1剤1日分	1日量で点数化 → 日数を掛ける
頓服薬	1調剤	1回量×回数の全量で点数化
外用薬・注射薬	1調剤	総量で点数化

頓服薬は「1回分ごと」ではありません。

調剤報酬の薬剤料では、頓服薬の所定単位は**1調剤**です。1回分で点数化して回数を掛けると、**回数**の分だけ**金額が跳ね上がります**。例: 差額分0.15円の薬を1回1錠10回分 → 正しくは $0.15 \times 10 = 1.5$ 円 → 1点 → **11円**。1回分ごとに点数化すると $1点 \times 10回 = 10点 \rightarrow 110円$ となり、10倍ずれます。

薬剤カード内の差額も、同じ計算方法を使っています。内服薬は1日量と日数、頓服薬は1回量と回数、外用薬・注射薬は総量を入れると、計算タブと同じ金額が出ます。

「計算」タブでは、薬を追加すると剤形を自動で判定して入力欄を切り替えます。外用薬を内服薬として日数を掛けてしまう誤りを防ぐためです。内服薬と頓服薬では入力欄の横に合計量が出るので、桁の取り違いにも気づけます。なお頓服薬は利用者が明示的に選ぶものなので、自動判定では上書きしません。

4. 剤(Rp)のまとめ方で金額が変わります

事務連絡には次の定めがあります。

- 同じ剤に複数の長期収載品があるときは、金額を合算してから点数化する
- 剤が複数あるときは、剤ごとに点数を出してから合算する

このため、同じ処方箋でも剤の立て方によって金額が変わります。差額分1円の薬を2つ処方した場合(14日分)、別々の剤なら308円、同じ剤なら154円になります。これは端数処理に由来するもので、薬剤料の計算方法そのものの性質です。

5. 患者負担の求め方

A 特別の料金 = 差額分の点数 × 10円 × 1.1 (消費税)
B 保険対象 = 選定療養時の薬価の点数 × 10円
C 自己負担 = B × 負担割合 (1~3割)

患者負担の総額 = A + C

6. 公式の計算例との照合

事務連絡の計算例(別添2)と突き合わせ、完全に一致することを確認しています。

項目	公式	このシステム	
1日分の点数(特別/保険)		5点/15点	5点/15点
A 特別の料金		1,650円	1,650円
B 保険対象となる費用		4,500円	4,500円
C 患者自己負担		1,350円	1,350円
患者負担の総額		3,000円	3,000円

条件:内服薬・1日2錠・30日分・3割負担、差額分25.35円/選定療養時74.65円

7. 計算に含まれないもの

薬剤料以外は含みません。調剤技術料・薬学管理料などは計算対象外です。

また端数処理の関係で、実際の請求額と数円ずれる場合があります。